11 Energéticos, cafeína e pré-treino: quanto é demais

A sensação de energia que o estimulante dá não melhora o condicionamento. As sociedades de pediatria desaconselham o energético nessa idade, e o teto de cafeína ajuda a conversar também sobre o café e o refrigerante do dia a dia.

POSIÇÃO PEDIÁTRICA

Energético não é para criança nem adolescente

- A Sociedade Brasileira de Pediatria considera os energéticos não apropriados para crianças e adolescentes[1].
- Para a Academia Americana de Pediatria, a cafeína e os outros estimulantes dos energéticos não têm lugar na dieta de crianças e adolescentes, e esses produtos não devem ser consumidos nessa idade[2].
- Pelos efeitos adversos e sobre o desenvolvimento, o consumo de cafeína deve ser desestimulado em todas as crianças[2].
- Já houve toxicidade importante com o consumo de vários energéticos; a cafeína pura em pó preocupa em particular e responde por pelo menos duas mortes de jovens. No esforço em ambiente quente, os estimulantes elevam a temperatura central[3].
- No Brasil, essas bebidas podem ter até 35 mg de cafeína por 100 mL, e o rótulo deve trazer em destaque: “Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto”[4].

TETO DE REFERÊNCIA

Cafeína até 18 anos: no máximo 2,5 mg/kg/dia

PESO	TETO DIÁRIO	DOSE DOS ESTUDOS EM ADULTOS
40 kg	100 mg	120 a 240 mg
50 kg	125 mg	150 a 300 mg
60 kg	150 mg	180 a 360 mg
70 kg	175 mg	210 a 420 mg

ENERGÉTICO NO LIMITE LEGAL BRASILEIRO[4]	
Lata de 250 mL	até 87,5 mg
Lata de 473 mL	até 165,6 mg, acima do teto de quem pesa menos de 66 kg

Teto de 2,5 mg/kg/dia proposto por precaução para crianças e adolescentes, com base em dados limitados; adolescentes mais velhos e mais pesados, de 14 a 18 anos, talvez tolerem a cafeína como adultos saudáveis[5]. Os estudos de desempenho em adultos usam de 3 a 6 mg/kg, e doses de 9 mg/kg ou mais aumentam náusea, ansiedade, insônia e inquietação[6]. A menor dose de desempenho já passa do teto.

SOME TODAS AS FONTES

Cafeína em bebidas e alimentos comuns

PRODUTO	PORÇÃO	CAFEÍNA
Café coado	237 mL (1 xícara grande)	135 mg
Café solúvel	237 mL	76 a 106 mg
Chá preto ou verde	237 mL	30 a 50 mg
Refrigerante de cola	355 mL (1 lata)	36 a 46 mg
Refrigerante de cola dietético	355 mL	39 a 50 mg
Achocolatado pronto	237 mL	8 mg
Chocolate ao leite	28 g	7 mg

Valores da tabela da agência de saúde do Canadá, que aplicou aos adolescentes o teto das crianças por falta de dados próprios dessa faixa[5]. Para energéticos e pré-treinos, use o valor do rótulo.

CONTA DE CONSULTÓRIO

Adolescente de 50 kg: teto de 125 mg por dia (2,5 × 50). Uma lata de energético de 473 mL no limite legal (até 165,6 mg) já passa do teto sozinha; uma xícara grande de café coado (135 mg) também. Juntas, já passam do dobro do teto; com uma lata de cola (36 a 46 mg), chegam a cerca de 2,7 vezes o teto[4,5].

SINAIS DE EXCESSO PARA PERGUNTAR

Náusea, ansiedade, insônia e inquietação aparecem com mais frequência nas doses altas usadas em estudos com adultos[6]; palpitação e tremor merecem a mesma pergunta.

PRÉ-TREINO

Não encontramos recomendação pediátrica específica. Na consulta, trate o pré-treino como produto com estimulante: peça o rótulo, some a cafeína de todas as fontes do dia e desaconselhe o uso.

BEBIDA ESPORTIVA NÃO É ENERGÉTICO

A bebida esportiva tem função limitada, em atividade intensa e prolongada; no dia a dia, o uso rotineiro deve ser evitado ou restrito, e a água é a bebida principal[2].

PERGUNTAS PARA A CONSULTA

- Toma energético ou pré-treino? Quantas doses por dia?
- Junto com café, chá-mate ou refrigerante de cola?
- Sente palpitação, tremor, ansiedade ou insônia?

COMO EXPLICAR AO ADOLESCENTE

“O energético muda a sensação de cansaço, mas o condicionamento continua o mesmo, e a cafeína em excesso pode tirar o sono e acelerar o coração. O que aumenta o seu rendimento no jogo é treino, comida e sono.”

FONTES

1. Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Nutrologia. Consumo de bebidas energéticas por crianças e adolescentes. Documento Científico nº 10. Rio de Janeiro: SBP; 2022 [citado 2026 out 12]. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23377c-DC-Consumo_BebEnergeticas_crc_e_adl.pdf
2. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition; Council on Sports Medicine and Fitness. Sports drinks and energy drinks for children and adolescents: are they appropriate? Pediatrics. 2011;127(6):1182-9. doi:10.1542/peds.2011-0965
3. LaBotz M, Griesemer BA; Council on Sports Medicine and Fitness. Use of performance-enhancing substances. Pediatrics. 2016;138(1):e20161300. doi:10.1542/peds.2016-1300
4. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 719, de 1º de julho de 2022. Dispõe sobre os requisitos sanitários das misturas para o preparo de alimentos e dos alimentos prontos para o consumo. Diário Oficial da União. 2022 jul 6; Seção 1.
5. Health Canada. Caffeine in foods [Internet]. Ottawa: Government of Canada; 2025 [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/caffeine-foods.html
6. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer DE, Peeling P, Phillips SM, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52(7):439-55. doi:10.1136/bjsports-2018-099027